Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:00
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:04
Temps mis	4 min 21 s
Points	4,60/9,00
Note	**10,22** sur 20,00 (**51,11**%)

Énoncé général

Aux urgences vous recevez :

- Une patiente qui décrit avoir ressenti une douleur thoracique latéralisée à droite lors d'un effort il y a 1 semaine environ et ayant persisté à bas bruit depuis. Il n'y a pas de fièvre, pas de majoration ni modification de l'expectoration ni notion de contage infectieux (notamment Covid) dans l'entourage.
- Apparition par la suite d'une dyspnée depuis 24 h et ce malgré la majoration de son oxygénothérapie au domicile.
- L'évolution est défavorable vers un tableau de détresse respiratoire vers 22h motivant l'appel du Service d'Aide Médicale Urgente quelques heures plus tard. La patiente est transportée au Service d'Accueil et de traitement des Urgences du CHU Félix Guyon après administration de trois aérosols de bronchodilatateurs.

Arrivée de la patiente au Service d'Accueil et de traitement des Urgences:

- Cliniquement : tableau de détresse respiratoire avec signes de lutte sans défaillance hémodynamique associée chez une patiente en sueurs, consciente (Glasgow 15) somnolente. L'auscultation montre un silence auscultatoire bilatéral.
- À la biologie de façon notable : pH 7.22 ; PaO2 145 mmHg ; PaCO2 69 mmHg ; Leucocytes 12.4 G/L.
- Elle est suivie pour une BPCO post tabagique et une hypertension artérielle.

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel est votre diagnostic ?

- a. Pneumopathie infectieuse base droite ✖
- b. Embolie pulmonaire
- c. Décompensation hypercapnique de bronchopneumopathie chronique obstructive
- d. Décompensation cardiaque avec pleurésie exsudative
- e. Aucune de ces propositions.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Décompensation hypercapnique de bronchopneumopathie chronique obstructive

---

Question 2

Correct

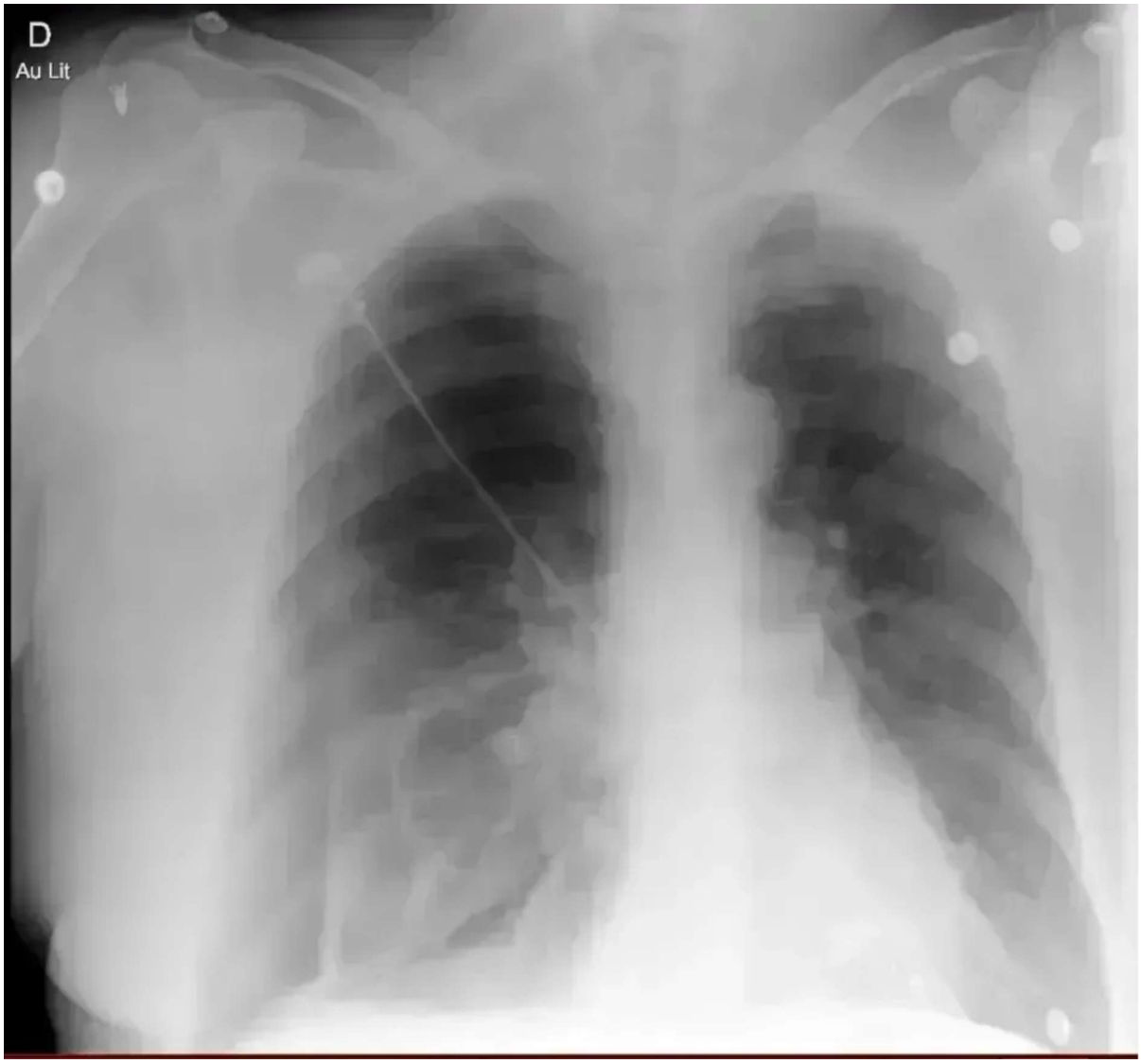
Note de 1,00 sur 1,00

Elle bénéficie d'une mise sous Ventilation Non Invasive apportant une amélioration clinique et gazométrique dans un premier temps (pH 7.34 ; pO2 78 mmHg ; pCO2 51 mmHg).

8h plus tard, échec de tentative de sevrage de Ventilation Non Invasive avec l'apparition d'une dyspnée inhibant la parole avec signes de lutte respiratoire.

La patiente est également agitée avec des sueurs profuses et un balancement thoraco-abdominal.

La radio suivante est réalisée:



Quel est votre diagnostic ?

- a. Embolie pulmonaire
- b. Exacerbation virale d'une BPCO
- c. Pneumothorax partielle droit ✔
- d. Pneumopathie base droite
- e. Pleurésie gauche

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Pneumothorax partielle droit

Question 3

Correct

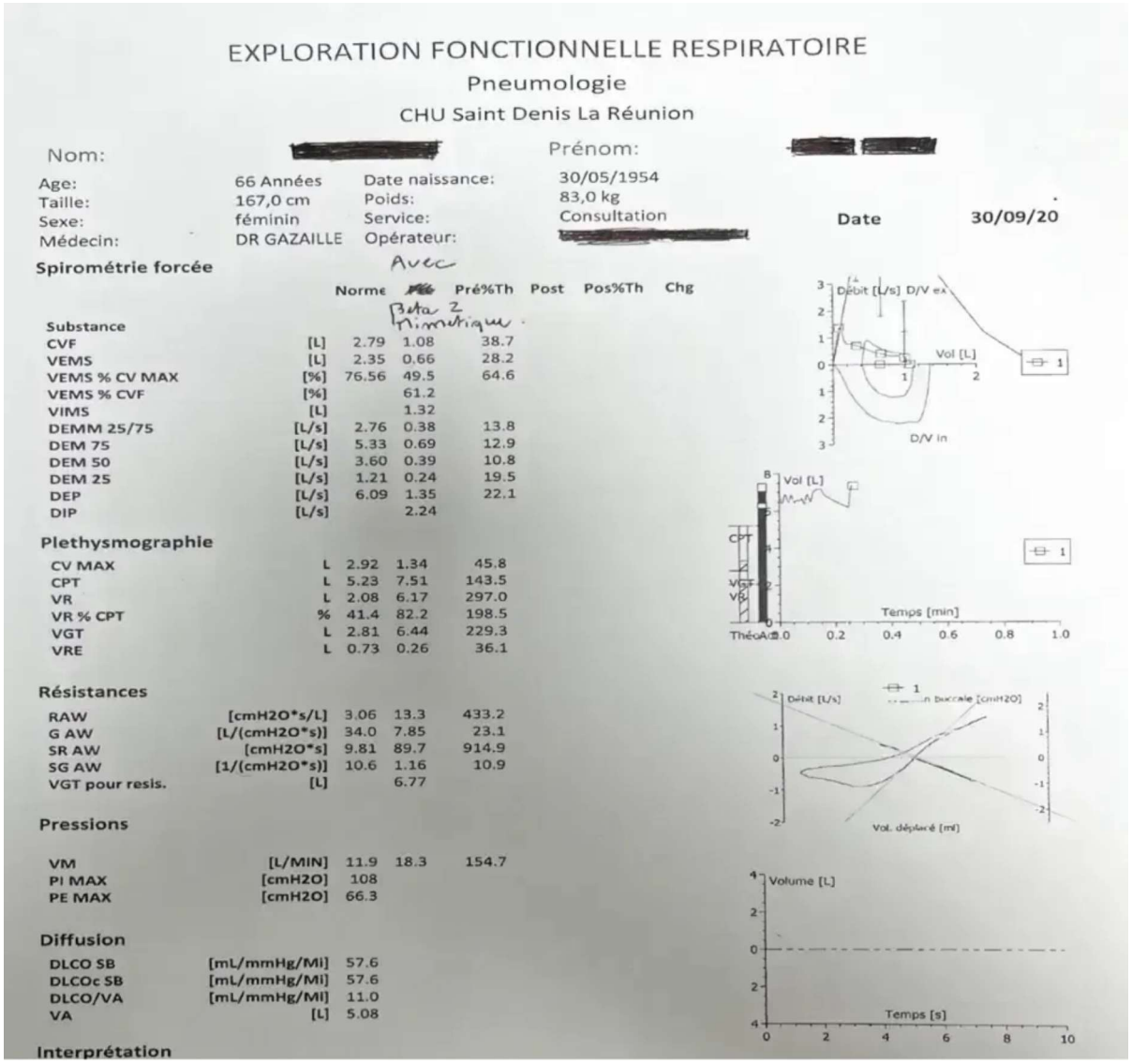
Note de 1,00 sur 1,00

La patiente est prise en charge en pneumologie puis regagne son domicile après 5 jours d'hospitalisation.

Avec un traitement bronchodilatateur par beta 2 mimétiques pour sa BPCO

Elle revient en consultation à 3 mois pour évaluation.

Les EFR sous beta 2 mimétiques sont les suivantes :



EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

Pneumologie

CHU Saint Denis La Réunion

Nom: [redacted] Prénom: [redacted]

Age: 66 Années Date naissance: 30/05/1954

Taille: 167,0 cm Poids: 83,0 kg

Sexe: féminin Service: Consultation

Médecin: DR GAZAILLE Opérateur: [redacted] Date 30/09/20

Spirométrie forcée — Avec Beta 2 mimétique

		Norme		Pré%Th	Post	Pos%Th	Chg
Substance							
CVF	[L]		2.79	1.08		38.7	
VEMS	[L]		2.35	0.66		28.2	
VEMS % CV MAX	[%]		76.56	49.5		64.6	
VEMS % CVF	[%]			61.2			
VIMS	[L]			1.32			
DEMM 25/75	[L/s]		2.76	0.38		13.8	
DEM 75	[L/s]		5.33	0.69		12.9	
DEM 50	[L/s]		3.60	0.39		10.8	
DEM 25	[L/s]		1.21	0.24		19.5	
DEP	[L/s]		6.09	1.35		22.1	
DIP	[L/s]			2.24			
Plethysmographie							
CV MAX	L		2.92	1.34		45.8	
CPT	L		5.23	7.51		143.5	
VR	L		2.08	6.17		297.0	
VR % CPT	%		41.4	82.2		198.5	
VGT	L		2.81	6.44		229.3	
VRE	L		0.73	0.26		36.1	
Résistances							
RAW	[cmH2O*s/L]		3.06	13.3		433.2	
G AW	[L/(cmH2O*s)]		34.0	7.85		23.1	
SR AW	[cmH2O*s]		9.81	89.7		914.9	
SG AW	[1/(cmH2O*s)]		10.6	1.16		10.9	
VGT pour resis.	[L]			6.77			
Pressions							
VM	[L/MIN]		11.9	18.3		154.7	
PI MAX	[cmH2O]		108				
PE MAX	[cmH2O]		66.3				
Diffusion							
DLCO SB	[mL/mmHg/Mi]		57.6				
DLCOc SB	[mL/mmHg/Mi]		57.6				
DLCO/VA	[mL/mmHg/Mi]		11.0				
VA	[L]		5.08				

Interprétation

Quelle propositions est vraie ?

- a. Syndrome obstructif sévère ✔
- b. Syndrome mixte
- c. Pas de syndrome restrictif
- d. Syndrome obstructif modéré
- e. Aucune de ces propositions n'est juste

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Syndrome obstructif sévère

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Elle ne rapporte aucune amélioration sur sa dyspnée, quelle modification thérapeutique peut être proposé ?

- a. L'ajout d'un corticoïde inhalé
- b. La mise en place d'une association fixe par bêta-2-mimétique et anticholinergique ✔
- c. La mise en place d'une association fixe par corticoïde inhalé et bêta-2-mimétique
- d. La mise en place d'un traitement par Ventoline systématique
- e. La mise en place d'une antibiothérapie en cours

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : La mise en place d'une association fixe par bêta-2-mimétique et anticholinergique

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les autres éléments de la prise en charge de votre patiente ?

- a. Arrêt du Tabac
- b. La vaccination pour la grippe ✔
- c. Arrêter la marche à cause de la dyspnée
- d. Pas de vaccin pour le pneumocoque
- e. La réhabilitation respiratoire

Vous en avez sélectionné correctement 1.

Les réponses correctes sont : Arrêt du Tabac, La vaccination pour la grippe, La réhabilitation respiratoire

---

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La patiente reviens vous voir six mois plus tard, car elle décrit depuis plus de 48 heures une majoration de sa dyspnée et des expectorations purulente qui la conduisent à une majoration de la consommation de Ventoline. Vous faites le diagnostic d'exacerbation de sa BPCO.

Quels signes de gravité recherchez vous ?

- [ ] a. Une aggravation rapide des symptômes
- [x] b. Une fréquence respiratoire supérieur à 30 cycles par minute ✔
- [ ] c. Un antécédent de séjour en réanimation pour exacerbation
- [ ] d. L'absence de comorbidité
- [ ] e. L'absence de tachycardie

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Une aggravation rapide des symptômes, Une fréquence respiratoire supérieur à 30 cycles par minute, Un antécédent de séjour en réanimation pour exacerbation

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les exacerbations de BPCO :

- [ ] a. La majorité des exacerbations ne sont pas d'origine infectieuse.
- [x] b. Le caractère purulent de l'expectoration est un élément en faveur d'une origine bactérienne. ✔
- [ ] c. *Haemophilus influenza* est souvent mise en cause.
- [ ] d. Le *Pseudomonas aeruginosa* est souvent mise en cause.
- [ ] e. Les exacerbations sont toujours d'origine virale.

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Le caractère purulent de l'expectoration est un élément en faveur d'une origine bactérienne., *Haemophilus influenza* est souvent mise en cause.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels examens complémentaires peuvent être demandés dans un premier temps ?

- [ ] a. Une radiographie thoracique
- [x] b. Un bilan biologique avec NFS, CRP, ionogramme et créatinine ✔
- [ ] c. Une fibroscopie bronchique avec lavage broncho alvéolaire
- [ ] d. Un électrocardiogramme
- [ ] e. Une recherche de BAAR

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Une radiographie thoracique, Un bilan biologique avec NFS, CRP, ionogramme et créatinine, Un électrocardiogramme

---

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Il s'agit du troisième épisode de ce type survenu au cours des six derniers mois, quelles propositions thérapeutiques peuvent être envisagées ?

- [ ] a. Un programme de réhabilitation respiratoire
- [x] b. Une trithérapie fixe, associant corticoïdes, inhalée , bêta-2-mimétique et anticholinergique ✔
- [ ] c. La mise en place d'un traitement antibiotique prophylactique
- [ ] d. L'arrêt des séances de kinésithérapie
- [ ] e. Aucune modification n'est envisagée.

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Un programme de réhabilitation respiratoire, Une trithérapie fixe, associant corticoïdes, inhalée , bêta-2-mimétique et anticholinergique